

URGENCES · RÉA · SOINS PALLIATIFS · PLASTIQUE

Fiches QE Haute Fréquence — déduplication + pièges (FAUX) + corrections regroupées — Version 1

Cross-match : 750 QEs officielles (Juin 2019 → Normal 2026 (15 sessions)) × Cours AIO FMPM 2026 (urg-aio · soins-palliatifs-aio · chir-plastique-aio) — Corrections officielles : e-qe.online

FMPM — Module Urgences/Réanimation, Soins palliatifs, Chirurgie plastique • Banque 750 QE

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 750 QEs (15 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	Chirurgie plastique (cicatrisation, pansements, greffes/lambeaux, escarres)	146 Q	Chir. plastique
2	Traumatisme grave & Coma (TCG, polytrauma, mort encéphalique)	107 Q	Réanimation
3	Trouble du milieu intérieur (équilibre acido-basique, dysnatrémies, dyskaliémies, ACD)	92 Q	Réanimation
4	Soins palliatifs	91 Q	Soins palliatifs
5	Réanimation cardio-respiratoire (ACR/RCP, AAG, IRA, SDRA)	86 (+1 SDRA) Q	Réanimation
6	Intoxications & Envenimations	77 Q	Réanimation
7	États de choc	73 (+2) Q	Réanimation
8	Douleur (évaluation, paliers OMS)	38 Q	Soins palliatifs
9	Brûlures (réanimation du brûlé)	19 Q	Réa / Plastique
10	Infections associées aux soins (PNAVM++)	18 Q	Réanimation

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 15 sessions, chaque examen ~50 questions.

Leçon officielle	Total	Moyl'examen	% d'examen
Chirurgie plastique	146	9.73	19.5%
Traumatisme grave & Coma	107	7.13	14.3%
Trouble du milieu intérieur	92	6.13	12.3%
Soins palliatifs	91	6.07	12.1%
Réanimation cardio-respiratoire (+SDRA)	87	5.80	11.6%
Intoxications & Envenimations	77	5.13	10.3%
États de choc (+inclassifiables)	75	5.00	10.0%
Douleur	38	2.53	5.1%
Brûlures	19	1.27	2.5%
Infections associées aux soins	18	1.20	2.4%
TOTAL (10 leçons — 750 QE, 15 sessions)	750 Q	50.0	100%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] CHIRURGIE PLASTIQUE — CICATRISATION, PANSEMENTS, GREFFES & LAMBEAUX, ESCARRES

Chirurgie plastique • ~10 Q/examen

□ Classification des escarres NPUAP I–IV · Règle des 9 de Wallace · Choix du pansement selon le type de plaie

Cicatrisation de 2^e intention — les 3 phases

- 3 phases successives : détersion → bourgeonnement (granulation) → épithélialisation.
- Détersion : élimination des tissus nécrotiques ; d'origine microbienne (flore saprophyte), ACCÉLÉRÉE par l'excision chirurgicale.
- Bourgeonnement : dépend directement de la qualité de la VASCULARISATION du lit de la plaie.
- Maturation / remodelage : réorganisation du collagène par les myofibroblastes, dure des MOIS, et AUGMENTE progressivement la résistance de la cicatrice.
- Δ FAUX : « la phase de maturation diminue la résistance de la cicatrice » — elle l'AUGMENTE.
- Δ FAUX : « la détersion est ralentie par l'excision chirurgicale » — l'excision l'ACCÉLÈRE.

□ Item récurrent ~10× (Jn2019→N2026).

Cicatrisation de 1^{re} intention

- Suture directe des plaies linéaires à berges nettes, peu contuses, suturées dans les lignes de Langer.
- Pas de perte de substance ; cicatrice fine.

□ S2024, J2023, Jn2021.

Greffes cutanées

- Greffe de peau TOTALE : prélève toute l'épaisseur (épiderme + derme entier) ; site donneur SUTURÉ ; prélèvement au bistouri ; revascularisée par le site receveur.
- Greffe de peau MINCE (dermo-épidermique) : prélevée au dermatome ; site donneur cicatrise SEUL (spontanément).
- Toute greffe est dépourvue de pédicule vasculaire propre (≠ lambeau).
- Δ FAUX : « le site donneur d'une greffe totale cicatrise spontanément » — il est SUTURÉ.

□ Récurrent ~10× (greffe totale).

Lambeaux

- Le lambeau CONSERVE son pédicule vasculaire (autonomie vasculaire), parfois rétabli par micro-anastomose (lambeau libre).
- Peut être composite (plusieurs tissus). Distinction clé vs greffe = présence du pédicule.
- Δ FAUX : « le lambeau est dépourvu de vascularisation propre ».

□ Jn2024, O2024, J2022.

Cicatrices pathologiques — chéloïde vs hypertrophique

- Chéloïde : activité fibroblastique EXCESSIVE ; DÉPASSE les berges de la plaie ; NE régresse PAS spontanément ; favorisée par l'âge JEUNE et l'ethnie (peau noire).
- Cicatrice hypertrophique : reste DANS les limites des berges ; régresse souvent (pressothérapie efficace).
- Traitement chéloïde = multimodal (corticoïdes intralésionnels, pressothérapie, etc.).
- Δ FAUX : « l'exérèse chirurgicale seule guérit définitivement la chéloïde » — exérèse isolée = RÉCIDIVE quasi constante.

□ Récurrent (chéloïde vs hypertrophique).

Pansements — indications par type de plaie

- Alginate (algues) : hémostatiques ; plaies exsudatives ou hémorragiques.

- Hydrocolloïdes : forment un gel d'aspect « pus-like » ; changer ≤ 1 semaine ; à ÉVITER si plaie infectée ; indiqués escarre stade II.
- Hydrogels : apportent de l'eau → plaies SÈCHES / nécrotiques.
- Films polyuréthane : plaie suturée / superficielle.
- Charbon actif : plaies MALODORANTES (+ pansement secondaire).
- VAC (pression NÉGATIVE) : favorise la circulation locale et la détersion.
- ⚠ FAUX : « les corticotulles favorisent le bourgeonnement » — ils l'INHIBENT.
- ⚠ FAUX : « les hydrocolloïdes sont indiqués sur une plaie infectée ».

□ Item pansements ~très récurrent.

Escarres — classification NPUAP & prévention

- Stade I : érythème qui ne blanchit pas. Stade II : atteinte épiderme $\pm$ derme (phlyctène).
- Stade III : atteinte de tout le tissu sous-cutané SANS dépasser le fascia. Stade IV : DÉPASSE le fascia (muscle/tendon/os).
- Facteurs EXTRINSÈQUES : pression + cisaillement + friction + macération. Facteur intrinsèque : immobilisation/dénutrition.
- Prévention = changement de position toutes les 2–3 h + supports + nutrition.
- Stade II → pansement hydrocolloïde.
- ⚠ FAUX : « changement de position toutes les 4 h suffit » — toutes les 2–3 h.
- ⚠ FAUX : « le stade III dépasse le fascia » — c'est le stade IV.

□ Récurrent (NPUAP).

Brûlures profondes en plastique

- Brûlure du 3^e degré circulaire (membre/thorax) → ESCARROTOMIE en urgence.
- Meilleur traitement d'une brûlure profonde = EXCISION-GREFFE précoce.
- Sulfadiazine argentique (Flammazine) : antimicrobien topique ; CONTRE-INDIQUÉE pendant la grossesse ; indiquée si colonisation/infection locale.
- ⚠ FAUX : « la Flammazine est autorisée chez la femme enceinte ».

□ Jn2023, J2021, Jn2019.

Brûlure électrique — vrai/faux classiques

- « Flash » électrique = brûlure THERMIQUE (arc) : pas de point d'entrée/sortie, pas de passage de courant transcorporel.
- Brûlure électrique VRAIE = point d'entrée + point de sortie + rhabdomyolyse → hyperkaliémie, $\uparrow$ CPK, troubles du rythme, IRA.
- ⚠ FAUX : « tout accident électrique est une brûlure électrique vraie » — le flash est THERMIQUE.
- ⚠ FAUX : « la brûlure électrique vraie n'entraîne pas de rhabdomyolyse ».

□ « Flash = thermique » récurrent ~10x.

Autres notions plastiques à connaître

- Expansion cutanée : exploite l'élasticité/plasticité de la peau ; prothèses gonflables siliconées ; ≥ 2 –3 temps opératoires.
- Ulcère de Marjolin : carcinome épidermoïde développé sur cicatrice ancienne (dégénérescence maligne).

□ O2024, J2023.

[RANG 2] TRAUMATISME GRAVE & COMA — TCG, POLYTRAUMATISÉ, MORT ENCÉPHALIQUE

Réanimation • ~7 Q/examen

□ Score de Glasgow (Yeux 4 · Verbal 5 · Moteur 6) · Critères de Vittel 2002 · TCG = GCS < 9

Score de Glasgow

- GCS = Y (/4) + V (/5) + M (/6), total 3–15.

- Réponse motrice : 6 obéit / 5 LOCALISE la douleur / 4 retrait / 3 flexion (décortication) / 2 extension (décérébration) / 1 nulle.
- Traumatisme crânien GRAVE = GCS < 9 ($\leq$ 8).
- **⚠ FAUX** : « M5 = flexion » — M5 = LOCALISE la douleur.

□ GCS = item le plus répété du module.

Lésions cérébrales primaires vs secondaires

- Lésions PRIMAIRES : immédiates, NON évitables et NON traitables (incluent les lésions axonales diffuses par accélération-décélération).
- Lésions SECONDAIRES : retardées, évitables → cible de la neuroprotection.
- Plaies du scalp : fréquentes et TRÈS hémorragiques. « Brain swelling » : plutôt chez l'ENFANT.
- Œdème vasogénique : rupture de la BHE + inflammation, pic à 24–48 h.
- **⚠ FAUX** : « les lésions primaires sont accessibles au traitement ».

□ Jn2024, J2022, Jn2021.

ACSOS (agressions cérébrales secondaires d'origine systémique)

- ACSOS : hypotension, hypoxémie, hypercapnie, HYPOcapnie, hyperglycémie, hyperthermie, anémie, dysnatrémie.
- Toute la PEC du TCG vise à les prévenir/corriger.
- **⚠ FAUX d'inclure parmi les ACSOS** : hypomagnésémie, hyperchlorémie, thrombopénie.

□ Item ACSOS récurrent.

PEC du traumatisé crânien grave

- Objectifs : homéostasie + neuroprotection + prévention des ACSOS ; PAM $\geq$ 90 mmHg ; normocapnie ; tête à 30° en position neutre ; approfondir la sédation.
- Osmothérapie (mannitol ou sérum salé hypertonique) si signes d'engagement.
- **⚠ FAUX** : « perfuser des solutés hypotoniques/glucosés » — à PROSCRIRE.
- **⚠ FAUX** : « corticoïdes systématiques » — NON indiqués dans le TCG.

□ S2024, J2023, J2020.

Coma — définition & 1^{re} mesure

- Coma = abolition de l'éveil ET de la conscience.
- Devant tout coma : doser la GLYCÉMIE de façon systématique (hypoglycémie = cause la plus rapide à éliminer/traiter).

□ Jn2023, J2021.

Mort encéphalique

- = destruction IRRÉVERSIBLE de l'encéphale, à cœur BATTANT.
- À différencier des comas prolongés et des états végétatifs.
- Détruit la thermorégulation hypothalamique ; entraîne un DIABÈTE INSIPIDE.
- Diagnostic CLINIQUE : abolition de tous les réflexes du tronc + abolition de la toux + apnée.
- Confirmation PARACLINIQUE : 2 EEG nuls OU angioscanner / artériographie (absence de flux).
- **⚠ FAUX** : « la mort encéphalique est réversible » / « le cœur est arrêté ».
- **⚠ FAUX** : « elle s'accompagne d'un SIADH » — c'est un DIABÈTE INSIPIDE.

□ Mort encéphalique = très récurrent.

Épreuve d'apnée (hypercapnie) & réanimation du donneur

- Pré-oxygénation FiO₂ 100 % pendant 10–15 min ; épreuve POSITIVE si aucun mouvement respiratoire à PaCO₂ $\geq$ 60 mmHg ; nécessite l'arrêt de la sédation.
- Réanimation de la mort encéphalique (prélèvement d'organes) : NORADRÉNALINE + remplissage + hématose + traitement du diabète insipide.

□ Jn2024, O2024.

Traumatisé grave — critères & bilan d'imagerie

- Critères de Vittel 2002 (5 catégories) : physiologiques (GCS<13, PAS<90, SpO₂ <90), cinétique (chute>6 m, éjection), lésions anatomiques, réanimation préhospitalière, terrain.

- Bilan initial au déchocage : Rx thorax + Rx bassin + Rx rachis cervical de profil + écho abdominale (FAST).
- Patient INSTABLE → FAST. Patient STABLE → BODY-SCANNER (bilan secondaire).
- **FAUX** : « le body-scanner est le 1^{er} examen chez le patient instable » — chez l'instable on fait la FAST.

□ Bilan initial / FAST récurrent ~8x.

Choc du traumatisé & vignette « pneumothorax compressif »

- Choc du traumatisé : surtout HÉMORRAGIQUE et OBSTRUCTIF (± médullaire si lésion cervicale).
- Vignette type motard non casqué (emphysème sous-cutané + turgescence jugulaire + collapsus) = PNEUMOTHORAX COMPRESSIF → geste salvateur = EXSUFFLATION/DRAINAGE thoracique ; cause du choc = traumatisme THORACIQUE.

□ Vignette pneumothorax compressif récurrent ~8x.

Antalgie du traumatisé

- Morphine en titration IV : diluer pour obtenir 1 mL = 1 mg ; surveiller fréquence respiratoire et conscience.

□ J2023, Jn2021.

[RANG 3] TROUBLE DU MILIEU INTÉRIEUR — ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE, DYSNATRÉMIES, DYSKALIÉMIES, ACIDOCÉTOSE

Réanimation • ~6 Q/examen

□ Trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) \approx 12 \text{ mmol/L}$ · Raisonnement de Henderson-Hasselbalch

Trou anionique & lecture d'une gazométrie

- Trou anionique (TA) = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; normale $\approx 12 \text{ mmol/L}$.
- L'accumulation de lactates (ou cétones) → acidose métabolique à TA ÉLEVÉ.
- Vomissements répétés → alcalose métabolique. BPCO (pH 7,32 / pCO₂ 60) → acidose respiratoire compensée.

□ Lecture de gaz du sang : item-pilier.

Vignettes gazométriques récurrentes

- Vignette « Mr S-M » (diarrhée ; pH 7,29 / HCO₃⁻ 14 / Na 128 / Cl 94) → acidose métabolique à TA ÉLEVÉ (TA ≈ 20).
- Vignette « Mr A-J » (pH 7,47 / pCO₂ 20 / HCO₃⁻ 14 / Cl 114) → alcalose respiratoire + acidose métabolique à TA NORMAL (trouble mixte).

□ Vignettes répétées ~6–7x (S-M / A-J).

ADH & diabète insipide

- ADH : ↑ la perméabilité à l'eau du tube collecteur (réabsorption d'eau).
- Stimulée par : ↓ volémie, ↓ PA, ↑ osmolarité plasmatique (osmorécepteurs).
- Diabète insipide : polyurie > 3 L/j + polydipsie ; le dosage de l'ADH distingue la forme centrale de la forme néphrogénique.
- **FAUX** : « l'ADH est stimulée par la sécrétion salivaire / directement par l'angiotensine comme mécanisme principal ».

□ ADH récurrent.

Dysnatrémies

- Hyponatrémie : éliminer une fausse hyponatrémie (hyperglycémie = hyperosmolaire) ; la vraie est hypo-osmolaire ; correction LENTE.
- Complication d'une correction trop rapide de l'hyponatrémie = MYÉLINOLYSE CENTROPONTINE (démýélinisation osmotique).
- Hypernatrémie → déshydratation intracellulaire ; risque d'une correction trop rapide = ŒDÈME cérébral.
- **FAUX** : « l'hyponatrémie profonde se corrige rapidement ».

□ Dysnatrémies récurrentes.

Dyskaliémies

- Hyperkaliémie ET hypokaliémie = urgences (troubles du rythme).
- Hyperkaliémie : ECG = ondes T amples, pointues, symétriques + élargissement du QRS ; traitement = gluconate de calcium + insuline-glucosé + β 2-mimétiques ($\pm$ épuration).
- Hypokaliémie : ECG = ondes U + sous-décalage ST + ondes T aplaties/inversées.
- Insuline et salbutamol $\rightarrow$ transfert intracellulaire du K^+ (font BAISSER la kaliémie).

□ N2026 (hyperK = item isolé), récurrent.

Acidocétose diabétique (ACD)

- Triade : hyperglycémie + cétose + acidose métabolique à TA élevé ; dyspnée de Kussmaul ; haleine acétonique.
- 2 facteurs déclenchants principaux : écart thérapeutique (arrêt insuline) + INFECTION.
- Traitement : réhydratation par SSI 0,9 % (1^{re} mesure) + insuline rapide IV 0,1 U/kg/h + apport de K^+ + ATB si infection ; orientation en réanimation/USI.
- Coma hyperosmolaire : DT2 âgé, hyperglycémie majeure SANS cétoacidose.
- ⚠ FAUX : « débiter l'insuline avant la réhydratation » et « administrer l'insuline malgré une kaliémie $< 3,5$ » — corriger d'abord le K^+ .

□ ACD récurrent (vignette + QCM).

[RANG 4] SOINS PALLIATIFS

Soins palliatifs • ~6 Q/examen

□ Définition OMS des soins palliatifs · Protocole d'annonce SPIKES · Étapes du deuil de Kübler-Ross

Définition & caractéristiques OMS

- Le malade est considéré comme un être VIVANT et la mort comme un processus NATUREL.
- Objectif = qualité de vie : soulager la douleur ET les autres symptômes ; intégrer les dimensions psychologiques et spirituelles ; préserver la dignité.
- Concernent le patient ET ses proches ; reposent sur une approche PLURIDISCIPLINAIRE.
- Ne hâtent ni ne retardent la mort.
- ⚠ FAUX : « approche monodisciplinaire ».
- ⚠ FAUX : « visent à prolonger la vie / à guérir ».

□ Définition OMS = item-pilier, très récurrent.

Obstacles au développement (OMS) & organisation au Maroc

- Obstacles : méconnaissance (politiques & soignants), freins financiers, freins culturels/sociaux, idée fausse « réservés aux cancéreux », opiophobie.
- Maroc : unités fixes (coordonnent les unités mobiles + formation/recherche) ; équipe mobile = soutien, écoute téléphonique, coordination.
- ⚠ FAUX : « l'acharnement thérapeutique fait partie des obstacles listés » — il n'y figure généralement pas.

□ Obstacles OMS récurrent.

Objectifs, espoir & éthique

- Définition des objectifs : nature/stade de la maladie + options thérapeutiques + désirs du malade (avec famille et équipe).
- Entretenir l'espoir = compétence du médecin + contrôle des symptômes + NON-ABANDON.
- Éthique : bienveillance/non-malfaisance + autonomie + consentement éclairé + droit du patient de douter et de NE PAS savoir.
- ⚠ FAUX : « décider seul, en excluant la famille ».
- ⚠ FAUX : « informer le patient même s'il ne veut pas savoir » / « écarter la bienveillance ».

□ Éthique/objectifs récurrent.

Démarche de soins & nutrition

- Démarche globale : évaluation préalable (interrogatoire + examen) PRIMORDIALE ; rechercher les symptômes gênants AVANT toute thérapeutique ; respecter le droit de refuser.
- Nutrition : adaptée au CONTEXTE ; voie ORALE privilégiée et fractionnée ; hydratation RAISONNABLE et non délétère.
- Évaluation nutritionnelle : clinique + biologique (albumine + préalbumine + CRP) + index pronostique.
- Soins de bouche OBLIGATOIRES ; antifongiques NON systématiques.
- **⚠ FAUX** : « hydratation massive ».
- **⚠ FAUX** : « doser les marqueurs tumoraux pour l'évaluation nutritionnelle ».

□ Nutrition/soins de bouche récurrent.

Annonce — protocole SPIKES

- S Préparer le cadre → P évaluer la Perception du patient → I obtenir son INVITATION → K donner l'information → E répondre aux Émotions (empathie) → S faire la Synthèse + plan.
- Adapter l'information au rythme et aux souhaits du patient.
- **⚠ FAUX** : « délivrer l'information sans accord préalable du patient ».
- **⚠ FAUX** : « ne pas répondre aux émotions ».

□ SPIKES récurrent.

Deuil & étapes de Kübler-Ross

- Étapes : choc/déni → colère → marchandage → dépression → acceptation.
- PEC du deuil : prise en charge globale + information honnête + réponse aux besoins de la famille.
- Facteurs de risque CIRCONSTANCIELS de deuil compliqué : mort subite, âge jeune du défunt, corps non récupéré, agonie prolongée.
- **⚠ FAUX** : « il faut empêcher la famille d'exprimer son deuil ».

□ Deuil / Kübler-Ross récurrent.

[RANG 5] RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE — ACR/RCP, ASTHME AIGU GRAVE, IRA, SDRA

Réanimation • ~6 Q/examen

□ Chaîne de survie · Définition de Berlin du SDRA ($P/F \leq 300$, $PEP \geq 5$) · Score CURB-65

Arrêt cardio-respiratoire & RCP

- Chaîne de survie : alerte → RCP de base → défibrillation → RCP spécialisée.
- Rythmes CHOQUABLES : FV + TV sans poulx + torsade de pointes (NON choquables : asystolie + DEM/AESP).
- Adrénaline : 1 mg IV/IO toutes les 3–5 min. Ratio compressions/insufflations = 30:2 ; O_2 15 L/min dès que possible.
- Amiodarone : FV/TV réfractaire après le 3^e choc (300 mg puis 150 mg).
- Capnographie ($EtCO_2$) : confirme l'intubation, la qualité du MCE et le retour à une circulation spontanée (RACS). Voie alternative = INTRA-OSSEUSE.
- Causes réversibles (4H/4T) : incluent tamponnade et pneumothorax compressif.
- **⚠ FAUX** : « atropine systématique dans la DEM » — protocole OBSOLETE.
- **⚠ FAUX** : « la capnographie sert à diagnostiquer l'intoxication au CO ».

□ ACR/RCP récurrent.

ACR chez la femme enceinte

- Récliner l'utérus vers la GAUCHE ; placer les mains un peu plus HAUT sur le sternum ; césarienne de sauvetage si pas de RACS > 4–5 min.
- **⚠ FAUX** : « maintenir le monitoring fœtal pendant la réanimation » — la priorité est la mère.

□ Jn2024, J2022.

Asthme aigu grave (AAG)

- Physiopath : bronchoconstriction + œdème de la paroi + hypersécrétion.

- Signes de gravité : FR $\geq$ 30, DEP $<$ 30 %, NORMOcapnie (PaCO₂ qui se « normalise »), pouls paradoxal, parole impossible.
- Signes d'ALARME (AAG quasi-fatal) : silence auscultatoire + épuisement + troubles de conscience + bradypnée/bradycardie.
- Traitement : O₂ + β 2-mimétiques INHALÉS + corticoïdes systémiques (0,5–1 mg/kg) $\pm$ anticholinergiques inhalés $\pm$ sulfate de Mg.
- **⚠ FAUX** : « antihistaminiques / ATB systématiques / intubation systématique » dans l'AAG.

□ AAG récurrent.

Insuffisance respiratoire aiguë & VNI

- IRA = altération de l'hématose (défaut d'échange, de pompe, $\pm$ d'extraction).
- Indications reconnues de la VNI : OAP cardiogénique, décompensation de BPCO, immunodéprimé, post-opératoire.
- **⚠ FAUX** : « la VNI est indiquée sur un pneumothorax non drainé » — c'est une CONTRE-INDICATION.

□ VNI récurrent.

SDRA — définition de Berlin

- Critères : début aigu $<$ 7 j ; opacités BILATÉRALES ; œdème NON cardiogénique (PAPO $\leq$ 18) ; PaO₂ / FiO₂ $\leq$ 300 avec PEP $\geq$ 5.
- Sévérité : léger 200–300 / modéré 100–200 / sévère $\leq$ 100 ; lésion de la membrane alvéolo-capillaire ; gazométrie ARTÉRIELLE.
- Ventilation protectrice : Vt 6 mL/kg de poids idéal + PEP + décubitus VENTRAL dans les formes sévères.
- **⚠ FAUX** : « le SDRA est d'origine cardiogénique ».

□ SDRA (Berlin) item rare mais tombé.

Pneumonie communautaire — CURB-65

- CURB-65 : Confusion + Urée $>$ 7 mmol/L + FR $\geq$ 30 + PA basse (PAS $<$ 90 ou PAD $\leq$ 60) + âge $\geq$ 65 ans.
- **⚠ FAUX** : « le sexe masculin fait partie du score CURB-65 ».

□ CURB-65, J2023.

[RANG 6] INTOXICATIONS & ENVENIMATIONS

Réanimation • ~5 Q/examen

□ Toxidromes (opioïde · anticholinergique · cholinergique · adrénergique) · Classes de gravité de l'envenimation scorpionique I–III

Envenimation vipérine (syndrome vipéridé)

- Douleur importante + TROUBLES DE L'HÉMOSTASE majeurs (coagulopathie) + syndrome de loge/nécrose locale.
- Test de coagulation sur tube sec au lit du malade.
- Sérum antivenimeux : DISPONIBLE au Maroc et efficace = traitement de choix.
- **⚠ FAUX** : « poser un garrot et scarifier » — à PROSCRIRE.

□ Vipère récurrent.

Envenimation par élapidé (cobra)

- Douleur mineure + ptosis + PARÉSIE/paralysie respiratoire (syndrome NEUROTOXIQUE) ; pas de troubles de l'hémostase.
- **⚠ FAUX** : « le cobra entraîne surtout une coagulopathie ».

□ S2024, J2022.

Envenimation scorpionique

- Mortalité la plus élevée chez l'ENFANT ; choc CARDIOGÉNIQUE.
- 3 classes : I (signes locaux) / II (signes généraux) / III (défaillance vitale, OAP).
- Traitement de choix de la défaillance = DOBUTAMINE ; classes II–III $\rightarrow$ hospitalisation.
- **⚠ FAUX** : « dopamine / remplissage massif en 1^{re} intention ».

- **⚠ FAUX** : « prise en charge ambulatoire d'une classe II ou III ».

□ Scorpion (dobutamine) récurrent.

Toxidromes

- OPIOÏDE : myosis + bradypnée + coma calme (antidote NALOXONE).
- ANTICHOLINERGIQUE : mydriase + bouche sèche + globe urinaire + iléus + tachycardie.
- ADRÉNERGIQUE : mydriase + HTA + tachycardie + sueurs.
- CHOLINERGIQUE / organophosphorés : myosis + hypersécrétions + fasciculations (antidote atropine).

□ Toxidromes récurrent.

Antidépresseurs tricycliques (ADT)

- Tableau : QRS large > 100–120 ms + choc cardiogénique + coma avec HYPERTONIE + syndrome anticholinergique.
- Traitement : charbon activé (± lavage si précoce) + BICARBONATE de Na molaire si QRS large + benzodiazépines si convulsions.
- **⚠ FAUX** : « administrer du flumazénil » (risque de convulsions) ; « l'hémodialyse est efficace sur les ADT ».

□ ADT récurrent.

Benzodiazépines & autres toxiques fonctionnels

- BZD : toxiques FONCTIONNELS, bénins ; coma HYPOTONIQUE ; anticonvulsivants (antidote FLUMAZÉNIL).
- Ecstasy : sympathomimétique → MYDRIASE.
- **⚠ FAUX** : « antidote des BZD = naloxone » — c'est le FLUMAZÉNIL.
- **⚠ FAUX** : « l'ecstasy donne un myosis ».

□ BZD/ecstasy récurrent.

Intoxication au paracétamol

- Hépatotoxicité RETARDÉE ; antidote = N-ACÉTYLCYSTÉINE le plus tôt possible ; surveiller le TP (< 50 % = gravité).
- Seuil toxique ≈ 200 mg/L à H4 (nomogramme de Rumack) ; traitement = lavage précoce + NAC.
- **⚠ FAUX** : « épuration extra-rénale / albumine » comme traitement du paracétamol.

□ Paracétamol récurrent.

Intoxication au CO & toxiques dialysables

- CO : gaz inodore, incolore, insipide ; affinité pour l'Hb >> O₂ ; SÉQUELLES neurologiques possibles ; GRAVE chez la femme enceinte ; antidote = OXYGÈNE (± oxygénothérapie hyperbare).
- Toxiques DIALYSABLES : méthanol, éthylène glycol, lithium, salicylés.
- **⚠ FAUX** : « l'oligurie est un signe caractéristique de l'intoxication au CO ».

□ CO récurrent.

[RANG 7] ÉTATS DE CHOC

Réanimation • ~5 Q/examen

□ qSOFA (PAS ≤ 100 · FR ≥ 22 · confusion) · Classification de Ring de l'anaphylaxie I–IV · Profils hémodynamiques des chocs

Profils hémodynamiques des chocs

- HYPOVOLÉMIQUE : ↓ débit cardiaque, ↑ RVS, ↓ pressions de remplissage.
- CARDIOGÉNIQUE : ↓ débit (index cardiaque < 2,2 L/min/m²), ↑ RVS, PAPO > 18.
- DISTRIBUTIF (septique/anaphylactique) : débit normal ou ↑, RVS EFFONDREES.
- Lactates ARTÉRIELS = marqueur diagnostique ET pronostique (sévérité + acidose métabolique).

□ Profils hémodynamiques récurrent.

Choc cardiogénique

- Cause la plus fréquente = INFARCTUS du myocarde / SCA.
- Critère hémodynamique = index cardiaque $< 2,2 \text{ L/min/m}^2$; traitement inotrope = DOBUTAMINE.
- ⚠️ *Anomalie corrigé officiel N2026 (Q13) : la « cause la plus fréquente » donnée comme « infection du myocarde » est ERRONÉE — la réponse attendue par le cours est l'IDM/SCA. À connaître pour ne pas être déstabilisé.*

□ Cause IDM récurrent $\sim 12\times$; anomalie clé N2026.

Choc anaphylactique

- Traitement de 1^{re} intention = ADRÉNALINE (IM puis titration IV).
- Classification de Ring : grade IV = arrêt cardio-respiratoire.
- Les antihistaminiques ne sont PAS un traitement du choc lui-même.
- ⚠️ *Anomalie corrigé officiel N2026 (Q15) : « noradrénaline en 1^{re} intention » est ERRONÉ — le traitement de 1^{re} intention du choc anaphylactique est l'ADRÉNALINE.*

□ Adrénaline récurrent $\sim 8\times$; anomalie clé N2026.

Sepsis & choc septique — qSOFA

- qSOFA (2/3) : PAS $\leq 100 \text{ mmHg}$ + FR $\geq 22/\text{min}$ + confusion (Glasgow < 15).
- SIRS = étape initiale, peut être NON infectieux. Physiopathologie du choc septique : atteinte de l'ENDOTHELIUM.
- Corticoïde utilisé = HYDROCORTISONE. Vasopresseur de référence = NORADRÉNALINE.
- ⚠️ *Anomalie corrigé officiel N2026 (Q16) : la combinaison incluant la SpO_2 est ERRONÉE — le qSOFA ne comporte PAS la SpO_2 (critères = PAS, FR, confusion).*

□ qSOFA récurrent $\sim 9\times$; anomalie clé N2026.

Choc hémorragique

- = choc hypovolémique. Triade létale : coagulopathie + acidose + hypothermie.
- Traitement PRINCIPAL = GESTE D'HÉMOSTASE (le remplissage/transfusion ne fait que temporiser).

□ Choc hémorragique récurrent.

Monitoring de la volémie

- Outils : ÉCHOCARDIOGRAPHIE, cathéter droit, PiCCO (épreuve de remplissage / variations respiratoires).

□ O2024, J2022.

[RANG 8] DOULEUR — ÉVALUATION & PALIERS OMS

Soins palliatifs • ~2-3 Q/examen

□ Paliers antalgiques OMS (3 niveaux) · Échelles EVA / EN / DN4

Mécanismes & généralités

- La douleur est une urgence thérapeutique, un motif fréquent, et reste SOUS-estimée.
- Douleur par excès de NOCICEPTION = la plus fréquente ; fibres Aδ (rapides) + fibres C (lentes, amyéliniques).
- Une douleur peut être MIXTE (nociceptive + neuropathique).
- ⚠️ *Discordance inter-sessions sur le « nombre d'étapes » de la transmission et sur les fibres myélinisées — bien relire l'énoncé exact avant de répondre.*

□ Mécanismes récurrent (avec pièges de formulation).

Évaluation de la douleur

- Évaluation INDISPENSABLE avant ET après le traitement, avec la MÊME échelle.
- EVA : réglette avec curseur côté patient / graduation côté soignant (très utilisée) ; réalisable chez le sujet âgé (sinon hétéro-évaluation).
- DN4 = dépistage de la douleur NEUROPATHIQUE.

□ Évaluation/EVA récurrent.

Paliers antalgiques OMS

- 3 paliers : I non-opioïdes (paracétamol, AINS, néfopam) ; II opioïdes faibles (tramadol, codéine) ; III opioïdes forts (morphine, fentanyl).
- Morphine = opioïde de référence (titration).
- Associations possibles : palier I + II, I + III, I + bloc/co-analgésique.
- ⚠ FAUX : « il existe 2 (ou 4) paliers OMS » — il y en a 3.
- ⚠ FAUX : « associer un opioïde faible (II) ET un opioïde fort (III) » — association NON recommandée.

□ Paliers OMS récurrent.

[RANG 9] BRÛLURES — RÉANIMATION DU BRÛLÉ

Réanimation / Plastique • ~1-2 Q/examen

□ Formule de Parkland ($4 \text{ mL} \times \text{kg} \times \% \text{SCB} / 24 \text{ h}$) · Règle des 9 de Wallace · Index de Baux

Choc du brûlé & physiopathologie

- Choc du brûlé = hypovolémique avec HÉMOCONCENTRATION (↑ hématicrite).
- Immunodépression ; hypokaliémie possible dès J3.
- Métabolisme = hypercatabolisme (état catabolique).
- ⚠ FAUX : « le choc du brûlé s'accompagne d'une hémO DILUTION » — c'est une hémO CONCENTRATION (récurrent ~6×).
- ⚠ FAUX : « il existe une sécrétion d'hormones anabolisantes ».

□ Hémococoncentration récurrent ~6×.

Réanimation hydrique — formule de Parkland

- Parkland : $4 \text{ mL} \times \text{poids(kg)} \times \% \text{SCB}$ sur 24 h ; la MOITIÉ sur les 8 premières heures, l'autre moitié sur les 16 h suivantes (demi-Parkland = 2 mL).
- Surveillance = DIURÈSE + hématicrite.
- Règle des 9 de Wallace pour la surface ; 3^e degré = anesthésie de la zone.
- ⚠ FAUX : « albumine en préhospitalier dès la 1^{re} heure ».
- ⚠ FAUX : « la diurèse ne fait pas partie de la surveillance ».
- ⚠ FAUX : « refroidir avec de l'eau glacée » ; « ATB systématique ».

□ Parkland/surveillance récurrent.

Gravité, brûlure électrique & pronostic

- Gravité = surface + profondeur + localisation + lésions associées + terrain.
- Brûlure électrique haut voltage (> 1000 V) : rechercher les lésions viscérales ; lésion cutanée souvent trompeuse ; réanimation hydrique adaptée (rhabdomyolyse).
- Index de Baux (âge + %SCB) = pronostic.
- ⚠ FAUX : « une brûlure du 1^e degré peut être qualifiée de grave ».

□ O2024, J2021.

[RANG 10] INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (PNAVM ++)

Réanimation • ~1 Q/examen

□ Définition IAS (délai ≥ 48 h) · Critères diagnostiques de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PNAVM)

Définition & transmission

- IAS = infection survenant au décours d'une prise en charge thérapeutique OU palliative ; délai ≥ 48 h après l'admission.
- Transmise surtout par les MAINS ; grave chez le sujet âgé.

□ Définition IAS récurrent.

Pneumonie nosocomiale / PNAVM

- Survient après 48 h ; 1^{re} cause d'IAS en réanimation ; germes = BGN.
- Facteurs de risque : ventilation > 6 j + troubles de conscience + traumatisme thoracique + troubles de déglutition + décubitus DORSAL.
- Critère diagnostique MAJEUR : nouvel infiltrat alvéolaire (+ purulence + hyperleucocytose ou leucopénie).
- **⚠ FAUX** : « la pneumonie nosocomiale est définie après 24 h » — c'est 48 h.
- **⚠ FAUX** : « germes = pneumocoque/H. influenzae » — ce sont des germes COMMUNAUTAIRES.
- **⚠ FAUX** : « le décubitus VENTRAL est un facteur de risque » — il est PROTECTEUR.

□ PNAVM = item dominant des IAS.

Moyens diagnostiques & autres IAS

- Seuils : LBA 10^4 , aspiration trachéale 10^5 , brossage protégé (PDP) 10^3 (= meilleur) ; sensibilité $\neq$ 100 %.
- Infection urinaire nosocomiale → sondage prolongé. Infection liée au cathéter (ILC) : 4^e cause ; diagnostic = hémocultures couplées (KT central + périphérique).
- Infection du site opératoire (ISO) : délai 30 j (1 an si implant). La méningite post-périmédullaire est la MOINS fréquente.

□ Moyens dx récurrent.

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS URGENCES-RÉANIMATION • SOINS PALLIATIFS • CHIRURGIE PLASTIQUE

** CLASSIFICATIONS & SCORES À MAÎTRISER **

Score de Glasgow (3–15)	Y/4 + V/5 + M/6 ; TCG = GCS < 9 ; M5 = LOCALISE
Critères de Vittel 2002	5 catégories : physiologiques / cinétique / anatomiques / réa préhosp / terrain
SDRA — définition de Berlin	P/F ≤ 300, PEP ≥ 5, opacités bilatérales, PAPO ≤ 18 ; sévère ≤ 100
qSOFA (≥ 2/3)	PAS ≤ 100 + FR ≥ 22 + confusion (PAS de SpO ₂)
Anaphylaxie — classification de Ring	Grade IV = arrêt cardio-respiratoire
Escarre — NPUAP I–IV	III = jusqu'au fascia (sans le dépasser) ; IV = dépasse le fascia
Formule de Parkland	4 mL × kg × %SCB / 24 h ; ½ sur 8 h, ½ sur 16 h
CURB-65	Confusion + Urée > 7 + FR ≥ 30 + PA basse + âge ≥ 65 (PAS le sexe)
Paliers antalgiques OMS	3 paliers (I non-opioïdes / II faibles / III forts)
Envenimation scorpionique	Classes I (local) / II (général) / III (défaillance vitale)

** MARQUEURS & SEUILS CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
Lactates artériels	Diagnostic ET pronostic de tout état de choc
Trou anionique ≈ 12	Na ⁺ - (Cl ⁻ + HCO ₃ ⁻) ; ↑ = acidose métabolique à TA élevé
PaO ₂ / FiO ₂ (P/F)	≤ 300 = SDRA ; ≤ 100 = forme sévère
GCS < 9 (≤ 8)	Définit le traumatisme crânien GRAVE
PaCO ₂ ≥ 60 mmHg	Seuil de positivité de l'épreuve d'apnée (mort encéphalique)
Index cardiaque < 2,2 L/min/m ²	Critère hémodynamique du choc cardiogénique
TP < 50 %	Gravité de l'intoxication au paracétamol
QRS > 100–120 ms	Toxicité des ADT → bicarbonate molaire
CPK / myoglobine ↑	Rhabdomyolyse (brûlure électrique vraie, écrasement)
Délai ≥ 48 h	Définit une infection associée aux soins / PNAVM

** PIÈGES CLASSIQUES (⚠ FAUX fréquents) **

- ⚠ *Corrigés officiels N2026 à connaître : choc cardiogénique « cause = infection du myocarde » (→ IDM/SCA), anaphylaxie « noradrénaline 1^{re} intention » (→ ADRÉNALINE), qSOFA « avec SpO₂ » (→ PAS/FR/confusion). Réponses-types du cours.*
- ⚠ *Choc du brûlé = hémoCONCENTRATION (et NON hémodilution).*
- ⚠ *Mort encéphalique = diabète insipide (et NON SIADH) ; irréversible, à cœur battant.*
- ⚠ *ADT : bicarbonate molaire si QRS large ; PAS de flumazénil, PAS de dialyse.*
- ⚠ *Antidote des benzodiazépines = flumazénil (et NON naloxone).*

- ⚠ « Flash » électrique = brûlure thermique (pas de point d'entrée/sortie).
- ⚠ Chéloïde : exérèse seule = récurrence ; dépasse les berges et ne régresse pas.
- ⚠ Hyponatrémie profonde : correction LENTE (risque de myélinolyse centropontine).
- ⚠ PNAVM : le décubitus ventral est PROTECTEUR (pas un facteur de risque).
- ⚠ Douleur : 3 paliers OMS ; ne jamais associer opioïde faible (II) + opioïde fort (III).

**** SÉQUENCES & ALGORITHMES À RESTITUER ****

- Chaîne de survie : alerte → RCP de base → défibrillation → RCP spécialisée.
- Déchocage du traumatisé : ABCDE → Rx thorax + bassin + rachis cervical + FAST → (si stable) body-scanner.
- Annonce SPIKES : cadre → perception → invitation → information → émotions → synthèse/plan.
- Deuil (Kübler-Ross) : déni → colère → marchandage → dépression → acceptation.
- Cascade des ACSOS à prévenir : hypotension, hypoxémie, hyper/hypocapnie, hyperglycémie, hyperthermie, anémie, dysnatrémie.
- Parkland : $\frac{1}{2}$ du volume sur les 8 premières heures, $\frac{1}{2}$ sur les 16 heures suivantes.

Généré par Claude.ai (Claude Opus 4.8) — Version 1

Cross-match 750 QEs officielles × Cours AIO FMPM 2026 (urg-aio · soins-palliatifs-aio · chir-plastique-aio) — Corrections officielles : e-qe.online

FMPM — Module Urgences/Réanimation, Soins palliatifs, Chirurgie plastique • Banque 750 QE

Améliorations Version 1 :

- ✓ Déduplication des 750 QE (15 sessions) en fiches haute fréquence par leçon.
- ✓ Pièges récurrents signalés explicitement en ⚠ FAUX (formulations-types des examens).
- ✓ Anomalies des corrigés officiels Normal 2026 isolées (choc cardiogénique, anaphylaxie, qSOFA).
- ✓ Citations par session pour tracer la provenance des items.
- ✓ PARTIE 4 : disclaimer conservé ; aucun topic certifié hors programme (descriptif officiel des modules non fourni).